



**Universidad
Norbert Wiener**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Obstetricia

**“FACTORES ASOCIADOS A LAS LESIONES CERVICALES PREMALIGNAS DETECTADAS MEDIANTE LA
PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA DEL CENTRO DE SALUD MIRONES BAJO, LIMA 2024”**

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE

Licenciado en Obstetricia

Presentado por

AUTOR: CARHUAVILCA ALVARADO, NAGHELY KHALITA

ORCID: 0000-0003-2484-3312

ASESOR: MG. DIEZ QUEVEDO, KARINA ELIZABETH

ORCID: 0000-0003-0432-2800

SALUD Y BIENESTAR

LIMA, PERÚ

2025

ÍNDICE

1.	EL PROBLEMA.....	4
1.1.	Planteamiento del problema	4
1.2.	Formulación del problema	5
1.2.1.	Problema general.....	5
1.2.2.	Problemas específicos.....	5
1.3.	Objetivos de la investigación	6
1.3.1.	Objetivo general.....	6
1.3.2.	Objetivos específicos.....	6
1.4.	Justificación de la investigación	6
1.4.1.	Teórica.....	6
1.4.2.	Metodológica	7
1.4.3.	Práctica.....	7
1.5.	Delimitaciones de la investigación.....	7
1.5.1.	Temporal	7
1.5.2.	Espacial	8
1.5.3.	Población.....	8
2.	MARCO TEORICO.....	8
2.1.	Antecedentes.....	8
2.2.	Bases teóricas	10
2.3.	Formulación de la hipótesis.....	17
3.	METODOLOGIA.....	18
3.1.	Método de la investigación.....	18
3.2.	Enfoque de la investigación	18
3.3.	Tipo de investigación	19
3.4.	Diseño de la investigación	19
3.5.	Población y muestra.	20
3.6.	Variable y operacionalización	20
3.7.	Criterios de Inclusión y Exclusión	23
3.8.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	24
3.8.1.	Técnica.....	24
3.8.2.	Descripción de instrumentos	24
3.8.3.	Validación.....	25
3.8.4.	Confiabilidad	25
3.9.	Plan de procesamiento y análisis de datos.....	26

3.10.	Aspectos éticos	27
4.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	27
4.1.	Recursos y Presupuesto	27
4.2.	Cronograma de Actividades.....	28
5.	REFERENCIAS.....	28
6.	ANEXOS	41
	Anexo 1: Ficha de Recolección de Datos.....	41
	Anexo 2: Validez del Instrumento	43
	Anexo 3: Informe del Asesor de Turnitin.....	47
	Anexo 4: Matriz de Consistencia	50
	Anexo 5: Cuadro de Operacionalización de Variables.....	51

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Alrededor del mundo el cáncer en el cérvix se posiciona dentro de los cuatro más comunes en féminas, con aproximadamente seiscientos sesenta mil casos nuevos, donde trescientos cincuenta mil de ellos fallecieron en el año 2022. (1) Se registra alta tasa de incidencia de este cáncer en África Subsahariana, el Caribe, América Latina y Melanesia, dónde casi el 70% del mayor número de casos recae en países con un nivel bajo de desarrollo. (2) A pesar de los avances de la ciencia, y con ello tratamientos médicos más atinados, hasta un 30% de las pacientes pierde la vida a causa de esta enfermedad, lo que conlleva una carga alta a nivel mundial. (3)

En nuestro país, Perú, el cáncer de cérvix es el segundo origen de defunción en féminas, donde doce de ellas son diagnosticadas por día y seis de ellas fallecen. Durante el año que inicio la pandemia, se identificaron 4270 nuevos registros de cáncer de cuello uterino (CCU), de ellos terminaron en mortalidad 2288 casos, poco más del 50% de los mismos. (4)

En Lima, para el primer trimestre del año 2024, el segundo principal tipo de cáncer es el de cérvix, con ciento cuarenta y dos casos registrados para ese tiempo; es el departamento con más incidencias registradas, seguido de Junín con noventa y cuatro casos, y Cajamarca con cincuenta y cinco. (5)

Para la precaución eficiente del CCU es crucial su detección temprana; aunque, existe la vacuna preventiva para el Virus del Papiloma Humano (VPH) solo cubre protección para algunas variantes de este, por tal motivo, es importante las pruebas de detección como citología cervical, inspección visual con ácido acético, pruebas del VPH y colposcopia. (6) (7) (8) A pesar de ello, se ha demostrado que el CCU es altamente evitable, con la prevención primaria

de CCU como la vacunación y secundaria con su detección; sin embargo, diversos factores influyen en inconveniente con la adherencia de las campañas de tamizaje, dentro de los cuales están incluido el factor socioeconómico, accesibilidad a los servicios de salud, el nivel de educación y factores culturales; para ello la implementación de la estrategia de la autotoma de muestra para la detección del VPH puede aumentar la asistencia al tamizaje, atrayendo a más féminas que se someten por primera vez a un cribado o que no se hicieron el tamizaje por mucho tiempo. (9) (10)

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuáles son los factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuáles son los factores sociodemográficos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024?

¿Cuáles son los factores gineco-obstétricos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024?

¿Cuáles son los factores conductuales asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024?

1.2.3. Objetivos de la investigación objetivo general

Identificar los factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.

1.2.4. Objetivos específicos

Distinguir los factores sociodemográficos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.

Reconocer los factores gineco-obstétricos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de papanicolaou en las en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.

Identificar los factores conductuales asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de papanicolaou en las mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de obstetricia del centro de salud Mirones Bajo, Lima 2024.

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Teórica

A pesar que el progreso científico ha permitido la posibilidad de disminuir cifras de mortalidad a causa del cáncer de cérvix y su prevención, gracias a la vacunación contra el VPH, además de los tamizajes de detección (8); se sabe que un gran número de féminas siguen padeciendo los efectos de contagiarse de alguna cepa del virus causante de este cáncer y fallecen alrededor del mundo; todo esto es porque aún existen vacíos en el conocimiento de factores concomitantes a esta afección; por tal motivo la presente investigación se centra en

identificar aquellos factores de lesiones cervicales premalignas para que luego puedan identificarse y estar alerta de encontrarlos en mujeres que se encuentran en riesgo de contraer el VPH y así poder disminuir las cifras de morbilidad y mortalidad.

1.3.2. Metodológica

La presente investigación presenta un diseño retrospectivo y es de tipo aplicada el cual permite el análisis y estudio de lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba del Papanicolaou; la metodología elegida permitirá resultados estadísticamente confiables y contribuye a la aplicación en futuros estudios.

1.3.3. Práctica

Las lesiones cervicales premalignas son un precursor tratable del cáncer de cuello uterino, lo que subraya la importancia crucial de la detección temprana; sin embargo, aún existen brechas como el acceso limitado a servicios de atención preventiva y la falta de conocimiento sobre los factores de riesgo conllevan a diagnósticos tardíos. Por tal razón, este estudio tiene como objetivo proporcionar información sobre la prevalencia de estas lesiones e identificar los factores asociados en mujeres en edad fértil. Los hallazgos podrían guiar a las autoridades en salud en la creación de estrategias de prevención dirigidas, como charlas de concienciación, campañas de tamizaje y programas educativos para las poblaciones en riesgo.

1.4. Delimitaciones de la investigación

1.4.1. Temporal

Al realizar el estudio, solo se consideró el periodo de tiempo de enero a diciembre del 2024.

1.4.2. Espacial

Solo se consideraron a las pacientes atendidas en el C.S. Mirones Bajo.

1.4.3. Población

En la unidad de análisis solo se valoraron a mujeres en edad fértil.

2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

Internacionales

Ramos D, et al. (2022) en su investigación en Cuba el objetivo fue “evaluar los factores de riesgo de lesiones premalignas del cérvix en mujeres en edad reproductiva del Policlínico Omar Ranedo 2020”, con el análisis de casos (47 féminas con diagnóstico de lesiones premalignas) y controles (113 mujeres con diagnóstico normal), elegidas por muestreo aleatorio simple, los factores asociados a CCU fueron inicio de coito sexual antes de los 18 años en 72.3% de los casos, pareja de riesgo (63.8%), afección ginecológica vaginal y cervical anterior (66.0%), determinaron que los factores mencionados son estadísticamente significativos y están asociados causalmente. (11)

Kurtay S, et al. (2022) ejecutaron un estudio retrospectivo con el objetivo de “proporcionar información sobre la frecuencia de las lesiones premalignas cervicales en Somalia”; analizaron resultados de frotis vaginal de 497 féminas, donde 63 de ellas tuvo lesiones premalignas (12.3%), la lesión más común fue ASC-US (células escamosas atípicas de significado incierto), determinaron que la incidencia de las lesiones cervicales premalignas en Somalia es superior a lo reportado en la literatura. (12)

Yordanov A, et al. (2023) analizaron las tendencias de cáncer de cuello uterino en Bulgaria, en un estudio retrospectivo con 7861 féminas que padecían la enfermedad entre 2013 y 2020 con un seguimiento hasta 2022; identificaron que tasa de incidencia había disminuido de 29.5 con cada 100 000 para el 2013 a 23.2 por cada 100 000 para el 2020, sin embargo, seguía siendo alta; además las pacientes detectadas en etapas iniciales de CCU disminuyeron, el 19% fueron diagnosticadas entre los 35 y 44 años de edad; por lo expresado, concluyeron que en naciones con un tamizaje en la población establecido el CCU es considerado una enfermedad rara, no siendo el caso de Bulgaria; si este cribado es realizado en edades más tempranas se mejorarían los resultados. (13)

Lakkis NA, et al. (2022) evaluaron la incidencia y tendencias del CCU en Líbano y las compararon con las tasas regionales y mundiales; la información estadística se adquirió del archivo nacional de cáncer de dicho país entre 2005 y 2016, la incidencia se expresó por 100 000 habitantes, encontraron los siguientes hallazgos: entre los años de búsqueda el CCU fue el décimo cáncer más común entre féminas, la tasa de incidencia más comunes fue en la mujeres de 70 a 74 años y 50 a 59 años, la tasa fue relativamente parecida a la de Australia, Norteamérica y algunos países del Occidente de Europa, e intermedia en comparación con otras naciones del Medio Oriente y el Norte de África; establecieron que la tasa de incidencia es baja en Líbano, por la baja prevalencia de infección por el VPH y otras ITS, y a los tamizajes oportunos. (14)

Nacionales

Aviles S, et al. (2023) realizaron un estudio transversal, analítico y descriptivo con el objetivo “determinar los factores asociados a tener un resultado patológico LIEAG (lesión intraepitelial escamosa de alto grado) en mujeres de una zona rural de la sierra central del Perú”, de 2656 mujeres encontraron que era más frecuente en diagnóstico de LIEAG en aquellas féminas con mayor edad, consumidoras de tabaco, mayor número de partos; concluyeron que

de 25 mujeres, una de ellas fue detectada con cáncer por anatomía patológica asociado a los factores de riesgo mencionados. (15)

Ruiz R. (2021) ejecutó una investigación analítica, observacional, retrospectivo, de casos y controles con el objetivo de “determinar los factores asociados a lesiones intraepiteliales (LIE) de cérvix en usuarias del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018”, fueron 1800 féminas tamizadas y 192 de ellas tuvieron un resultado positivo de las cuales 64 tuvieron LIE, identificaron a los siguientes factores de riesgo: procedencia de zona rural, estado civil no unidas, no tener grado de instrucción o solo primaria, y más de dos parejas sexuales; concluyeron que aquellas féminas que presentan los factores de riesgo mencionados son predisposición de tener LIE de cuello uterino. (16)

2.2. Bases teóricas

Lesiones Cervicales Premalignas (LCP)

Una neoplasia en el cérvix empieza con una lesión premaligna intraepitelial, alojada en la zona de metaplasia escamosa, que está en la unión del epitelio cilíndrico y escamoso del cuello del útero. (17) En la zona de transformación, que es donde se unifican las células escamosas y glandulares, o también llamada unión escamocilíndrica, se encuentran las lesiones precancerosas del cérvix, esta zona es vulnerable a infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano. (18)

Según la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello Uterino, aprobada por la Resolución Ministerial N.º 1013-2016/MINSA, las lesiones cervicales premalignas no presentan síntomas, incluyendo el cáncer invasor en temprano estadio, tiene una sintomatología escasa; las LCP se pueden diagnosticar mediante biopsia, examen físico (pélvico), diagnóstico diferencial, y exámenes auxiliares como el Papanicolaou o citología cérvico-uterina, inspección visual con ácido acético, colposcopia y

prueba molecular para el VPH, el cual es el principal causante del cáncer cervical, las LCP tardan de diez a veinte años en convertirse en un cáncer invasor, una detección precoz mediante el tamizaje oportuno y tratamiento de estas lesiones, previenen el CACU. (19)

Para el año 2017, se aprobó el Documento Técnico: Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino 2017-2021 mediante la Resolución Ministerial N.º 440-2017/MINSA, allí relatan que los factores que favorecen altos casos de CACU es multifactorial, entre ello escaso tamizaje, entrega de resultados tardío, idiosincrasia poblacional, no seguimiento de casos positivos o alterados y pocos centros de tratamiento; en este plan se centran en mejorar la cobertura del tamizaje del CACU y cobertura, mencionándose la auto-toma, además de brindar atención oportuna para casos de LCP y CACU. (20)

En 2019, se aprueba la Directiva Sanitaria N°085-MINSA/DGIESP/2019 “Directiva Sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones cervicales premalignas incluyendo carcinoma in situ”, mediante la Resolución Ministerial N°576-2019/MINSA, allí se relata que para una detección se debe diagnosticar la enfermedad cuando aún existe un alto potencial de cura mediante el tamizaje; cuando no hay acceso a la prueba molecular de VPH se establece “Ver y Tratar” que consiste en realizar la inspección visual con ácido acético (IVAA) cuando hay sospecha de LCP, sin necesidad de una comprobación diagnóstica con histopatología, el tratamiento se realiza con prontitud. (21)

Asimismo; en la Directiva Sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino N.º 165-MINSA/DGIESP-2025, aprobada por Resolución Ministerial N° 480-2025/MINSA, se establecen lineamientos para la prevención, detección y manejo de las lesiones premalignas del cuello uterino; detallan las edades de la población objetivo para tamizaje, en caso del Papanicolaou o citología cervical (población objetivo de 25 a 29 y 50 a 64 años, VIH+ 50 a 64

años, de 30 a 49 si no se cuenta con prueba molecular e IVAA, gestantes de 25 años o más que no se hayan realizado un tamizaje anteriormente), IVAA (30 a 49 años, VIH+ 25 a 49 años), prueba molecular de VPH (30 a 49 años, VIH+ 25 a 49 años); además, mencionan que una citología positiva comprende ASC-US, ASC-H, AGC, LIE BJ, LIE AG o carcinoma, donde los de alto riesgo son el 2°, 3° y 5°. (22)

ASC-US, por las siglas en inglés de Atypical Squamous Cells of Undetermined significance, lo que en español significa células escamosas atípicas de significado indeterminado; es un cambio benigno, pero anormal, y potencialmente serio que no es posible clasificarlo con certeza, es muy común que este ligado a una infección por el virus del papiloma humano, se considera una lesión de bajo grado. (23)

ASC-H, por las siglas en inglés de “atypical squamous cells-cannot exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion”, lo que en español significa células escamosas atípicas, no puede excluirse una lesión intraepitelial escamosa de alto grado; es una interpretación poco común, este resultado se relaciona histológicamente con el hallazgo de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, por tal motivo se recomienda referir a colposcopia. (24)

AGC, por las siglas en inglés de Atypical Glandular Cells, lo que en español significa células glandulares atípicas, esta categoría diagnóstica es poco reproducible e incluye: “células endocervicales atípicas; células endometriales atípicas; células glandulares; células endocervicales atípicas que favorecen neoplasias; células glandulares atípicas que favorecen neoplasias; carcinoma endocervical *in situ*; adenocarcinoma, endocervical o endometrial, o extrauterino”. (25)

LSIL, por las siglas en inglés Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, lo que significa en español lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIE BG), es una lesión que podría representar una infección transitoria con virus del papiloma humano y remiten con el

tiempo, es ligeramente anormal; este tipo de afección tiene características sugestivas, pero no diagnosticas de lesión escamosa intraepitelial de alto grado, por lo que es igual de relevante. (26)

HSIL, por las siglas en ingles High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, lo que significa en español lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIE AG); se refiere a los cambios morfológicos asociados con el extremo superior del espectro LIE, este tiene una mayor probabilidad de progresión a cáncer y menor tasa de regresión; se puede encontrar con cualquier otra anomalía escamosa o glandular. (27)

Factores Asociados a LCP

Factores Sociodemográficos

Edad, las mujeres de 46 a 55 años tienen 3,8 veces más probabilidades de tener lesiones cervicales premalignas que las féminas de 25 a 35 años, y quienes tienen de 56 a 65 años 12,2 veces más probabilidad, esto es porque las anormalidades cervicales precancerosas demoran en desarrollarse y se asocia a un largo periodo de infección por el virus del papiloma humano. (28)

Estado conyugal, las mujeres casadas tienen menos probabilidad para LCP, al contrario de las mujeres solteras, con nuevas parejas sexuales, divorciadas o separadas, donde en ellas existe una unión indirecta para LCP, pero vinculado con otros factores asociados. (29)(30) El estado conyugal se clasifica en *mujeres en unión* y en *mujeres que no están en unión*; en la primera división están la féminas casadas y convivientes; en la segunda, las féminas solteras, divorciadas, separadas y viudas. (31)

Factores Gineco-obstétricos

Paridad; el hecho de tener más de dos partos se asocia a padecer una LCP y CACU, esto debido principalmente a la interacción de factores físicos y conductuales, el parto puede

llegar a causar traumas mecánicos en el cuello del útero, lo que hace que susceptible al tejido cervical para infección y transformaciones. (32) (33)

Gravidez; la gestación es un factor asociado indirectamente con las LCP debido a los cambios hormonales que padecen las embarazadas, además de los anatómicos e inmunológicos, pueden llegar a facilitar la persistencia del VPH y empeorar la progresión de las LCP. (34)

Inicio de relaciones sexuales, existe asociación entre la primera relación coital precoz y las lesiones premalignas , esto se explique porque durante la adolescencia hay cambios anatómicos y fisiológicos en el tejido cervical, que fue reconocido como el sitio en que se aloja el virus del papiloma humano, el causante de CACU, por tal motivo este hecho es predisponente para desarrollar una lesión premaligna en el cérvix. (35) El inicio temprano de relaciones sexuales en féminas es antes de los 15 años, y luego de ello se considera no temprano. (36)

Infección de transmisión sexual (ITS), padecer de una ITS tiene una asociación significativa de padecer LCP, en especial el Virus del Papiloma Humano, ya que es el causante del CACU, además la clamidia y herpes genital pueden provocar inflamación crónica en el cérvix, lo que daña la barrera del epitelio cervical, y baja la inmunidad al igual que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) dificultando la eliminación del VPH. (37) (38) Una infección persistente por cualquiera de los serotipos del VPH, infecta a las células de la capa basal del epitelio del cérvix en la zona de transformación, esto contribuye a LCP. (39) Las féminas que están infectadas con el VIH tienen una alta tasa de padecer de LCP. (40)

Antecedente Familiar de cáncer de Cuello Uterino, se sabe que el principal causante de CCU es el virus del papiloma humano; sin embargo, existe asociación significativa entre este factor y las LCP, la razón de ello es que está presente la predisposición genética, algunas mutaciones de ellas debilitan la capacidad del sistema inmunológico, además estos genes

podrían estar alterados y no desempeñan correctamente sus funciones, como en el caso de los genes relacionados en la reparación del ADN, no ejercen la capacidad de prevenir daños celulares que conducen al desarrollo de cáncer. (41)

Método anticonceptivo, el uso de Anticonceptivos Orales (ACO) es un factor predisponente de padecer una lesión premaligna, con hasta 3 veces más de aquellas que no utilizan este método, esto podría estar relacionado a un trastorno hormonal endógeno, además que aumenta las hormonas que agravan que algunas células se multipliquen mucho más de lo normal, lo que aumenta la susceptibilidad de las células cervicales a una infección persistente por serotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo; y el no uso del condón. (42) (38)

Número de parejas sexuales (PJ), las féminas que con más de dos parejas sexuales tienen mayor probabilidad de desarrollar lesiones premalignas en el cuello del útero, esto aumenta tener coitos más frecuentes y sin protección, así el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual como el virus del papiloma humano. (43) (44) La clasificación para el número de parejas sexuales se divide en: una pareja sexual como muy bajo historial para PJ, entre dos a cuatro como bajo historial para PJ, entre cinco a nueve como moderado historial para PJ, y de diez a más parejas como alto historial para PJ. (45)

Factores conductuales

Tabaquismo; fumar tabaco expone al desarrollo de lesiones cervicales premalignas en comparación con aquellas mujeres que no lo hacen, esto no solo juega un papel importante en el CACU, sino también en la progresión de las lesiones premalignas; se debe a que el benzo(a)pireno (BaP) está presente en el tabaco y causa la amplificación de la replicación del virus del papiloma humano en las células cervicales, así como a los oncogenes E6 y E7 del VPH, estos componentes son vitales para el desarrollo de estas lesiones; además, afecta el

sistema inmune negativamente contra la infección con el VPH, favorece la persistencia y evolución de las lesiones premalignas. (46)

Alcoholismo, el consumo de alcohol tiene importancia estadística como factor de riesgo para LCP, esto se debe a que esta sustancia tiene un efecto inmunosupresor, su consumo en exceso podría llegar a debilitar el sistema inmunológico, lo que reduce la capacidad para combatir infecciones como el virus del papiloma humano; además, interfiere en el metabolismo de nutrientes como la vitamina B9, A y E, las cuales son esenciales para mantener la salud epitelial y así la prevención de daño celular en el cérvix; por otro lado los efectos del alcohol está relacionado con conductas sexuales de riesgo y sin protección de barrera como el condón aumentando así la exposición al VPH. (47)

Mujer en edad fértil

La dama en edad fértil es dicha fémina que tiene la competencia de reproducción, es decir que puede concebir un nuevo ser y llegan a término un embarazo; se encuentra en el rango de quince a cuarenta y nueve años. (48)

Prueba de Papanicolaou

Es una prueba de las células del cuello uterino por lo general, allí se realiza frotis con el citocepillo en el cérvix, exactamente en la zona de transformación, tiene una sensibilidad aproximada del 50%, los resultados anormales están establecidos según el sistema Bethesda 2014, que son los siguientes: “probable infección de virus del papiloma humano, ASC-US, ASC-H, AGC, LIE BG, LIE AG o carcinoma” (49)

El tamizaje periódico con la prueba de Papanicolaou en féminas adultas que mantienen relaciones sexuales ha sido el pilar para la detección de cáncer de cuello uterino, esta se basa en la evaluación morfológica de las células cervicales. (50)

Sistema Bethesda

Es un informe de los diagnósticos citológicos cervicales, tuvo su aparición por primera vez fue en 1988, posteriormente tres actualizaciones en 1991, 2001 y 2014, perfeccionando así la terminología y clasificación presentados en los informes de citología cervical; todo esto para mejorar la comunicación desde el laboratorio al personal clínico. (51)

El sistema Bethesda 2014 para informar sobre citología cervical consta de cinco partes: tipo de muestra, adecuación de la muestra, categorización general, interpretación o resultado y pruebas complementarias; del primero, puede ser preparación en base líquida o frotis (prueba de Papanicolaou); del segundo, la calidad de la muestra es satisfactoria para la evaluación (se describe presencia o no de cona de transformación u otro indicador de calidad) o no satisfactoria donde se especifica el motivo; del tercero, allí se marca si es negativo para lesión intraepitelial o malignidad, o anormalidad de células epiteliales de forma general; del cuarto, la interpretación es negativo cuando no existe evidencia de células neoplásicas, dentro de los hallazgos no cancerígenos están: variaciones celulares no neoplásicas, como metaplasia escamosa, cambios queratósicos, metaplasia tubárica, atrofia, cambios asociados al embarazo, cambios celulares reactivos asociados a inflamación, cervicitis coilocítica, radiación, uso del dispositivo intrauterino, y cambios celulares debido a tricomonas, candida spp., vaginosis bacteriana, virus del herpes simple, citomegalovirus; del quinto, se especifica si hay celular endometriales (mujeres de más de 45 años de edad). (52) (53)

2.3. Formulación de la hipótesis

Ho: No existen factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.

H1: Existen factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.

3. METODOLOGIA

3.1. Método de la investigación

Hipotético deductivo, la presente investigación utiliza este método ya que toma como punto de partida una hipótesis, la cual plantea la asociación entre ciertos factores y las lesiones cervicales premalignas; también, a través de la recolección y análisis de los datos, se busca comprobar o rechazar dicha hipótesis en base a los resultados del estudio. Este método científico está basado en la inferencia, constituye una estructura determinada cíclica con los pasos de: identificación de un problema, su planteamiento, formulación de hipótesis, con respecto a los datos, su recopilación y análisis, y evaluación de los resultados; todo este seguimiento con la finalidad de analizar la validez de una teoría. (54)

3.2. Enfoque de la investigación

Cuantitativo, según Creswell W. y Creswell J. (55) este enfoque se caracteriza por estar basado en la compilación de datos y la valoración de la información numérica, utiliza métodos estadísticos para poner a prueba una hipótesis, con el fin de generalizar los resultados a una mayor población; también sigue una estructura lógica y deductiva, inicia desde la formulación de una hipótesis, donde los datos recolectados sirven para confirmarla o refutarla.

3.3. Tipo de investigación

Aplicada, se emplea este tipo de investigación debido a que nos centramos en comprender una problemática real del sector salud, con el fin de generar conocimiento útil que permita conocer cuáles son los factores asociados a las lesiones cervicales premalignas, con el propósito de contribuir a la prevención y detección oportuna de LCP. Según Creswell W. y Creswell J. (55) este tipo de investigación se enfoca en la resolución de problemas prácticos y la respuesta a necesidades específicas en un contexto real, cuyo principal fin no es proporcionar un conocimiento teórico sino soluciones prácticas para un problema concreto; para ello utiliza métodos científicos orientados a mejorar prácticas profesionales o abordar desafíos en áreas como salud, educación o tecnología; se basa en recolectar datos importantes para generar una recomendación que se pueda implementar de manera directa.

3.4. Diseño de la investigación

No experimental, en este tipo de diseño, el investigador no manipula adrede las variables de estudio, ni controla sus condiciones; por otro lado, se restringe a solo analizar e inspeccionar los acontecimientos tal cual se presentan en su entorno, sin intervención directa; suele ser utilizado para explorar tendencias y generar una hipótesis para estudios posteriores experimentales. (56)

Corte transversal, es un diseño de investigación de tipo observacional que analiza datos recopilados de una población en específico en un espacio y periodo de tiempo determinado, permite evaluar la prevalencia de características o condiciones puntuales, explorar y analizar factores de riesgo; son eficientes para describir patrones de una enfermedad y generar hipótesis. (57)

Nivel correlacional, cuyo fin es examinar y medir una relación entre variables sin manipulación, busca determinar si están asociadas las variables, no implica causalidad solo indica la relación estadística entre las mismas; este tipo de nivel de estudio se utilizan comúnmente mediante encuestas o análisis de datos preexistentes, con coeficientes de correlación para medir la fuerza y dirección de la asociación. (58)

3.5. Población y muestra.

La población está comprendida por 38 historias clínicas de las féminas en edad fértil (15 a 49 años) con resultado alterado de la prueba de Papanicolaou, evaluadas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima, 2024.

Dado que el tamaño poblacional fue accesible y manejable, se optó por trabajar con el total de la población, por lo que no se realizó un procedimiento de muestreo probabilístico ni no probabilístico. En consecuencia, se empleó un muestreo censal, que incluye a todas las mujeres que cumplen con los criterios de inclusión establecidos.

Este enfoque permitió maximizar la representatividad de los datos y obtener resultados más precisos sobre la relación entre los factores asociados y las lesiones cervicales premalignas en el grupo de estudio.

3.6. Variable y operacionalización

Factores asociados: Condiciones que influyen en la aparición de las lesiones cervicales premalignas; estas características presentadas en mujeres en edad fértil están asociadas a lesiones cervicales premalignas.

Lesiones Cervicales Premalignas: Modificaciones celulares del cérvix que podrían volverse cáncer, se identifica mediante el resultado de la prueba de Papanicolaou realizada en mujeres en edad fértil.

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Factores asociados	Condiciones que influyen en la aparición de las lesiones cervicales premalignas.	Características presentadas en mujeres en edad fértil asociadas a lesiones cervicales premalignas.	Factores Sociodemográficos	Edad	Nominal	Mujer en edad fértil (15 a 49 años) a. Etapa Adolescente (15 a 17) b. Juventud (18-29) c. Etapa adulta (30-49)
				Estado Conyugal	Nominal	a. Mujeres en Unión b. Mujeres que no están en unión
				Grado de instrucción	Ordinal	a. Primaria b. Secundaria c. Estudios superiores
			Factores Gineco-obstétrico	Paridad	Nominal	a. Primípara b. Multípara
				Gestante	Nominal	a. Si b. No
				Inicio de relaciones sexuales	Intervalo	a. Inicio sexual temprano (<15 años) b. Inicio sexual no temprano (≥ 15 años)
				Antecedente de Infección de transmisión sexual	Nominal	a. Si b. No
				Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino	Nominal	a. Si b. No
				Clase de método anticonceptivo usado	Nominal	a. De barrera b. Hormonal c. Definitivo

				Número total de parejas sexuales	Nominal	a. 1 (Muy bajo historial) b. 2-4 (bajo historial) c. 5-9 (moderado historial) d. >9 (alto historial)
			Factores conductuales	Tabaquismo	Nominal	a. Si b. No
				Alcoholismo	Nominal	a. Si b. No
Lesiones cervicales premalignas	Modificaciones celulares del cérvix que podrían volverse cáncer.	Se identifica mediante el resultado de la prueba de Papanicolaou realizada en mujeres en edad fértil.	Grado de la lesión cervical premaligna.	Resultado citológico de la Prueba de Papanicolaou	Nominal	a. LIE bajo Grado b. LIE alto grado

3.7. Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de Inclusión

En la presente investigación se incluirán a todas las pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

1. Fémimas entre 15 a 49 años.
2. Evaluadas en el servicio de Obstetricia del Establecimiento de Salud Mirones Bajo, en Lima, durante el año 2024.
3. Que se hayan realizado la prueba de Papanicolaou en el establecimiento de salud durante el periodo de estudio.
4. Con diagnóstico citológico de la prueba de Papanicolaou alterado compatible con lesión cervical premaligna (LIE BG, LIE AG).
5. Con Historia Clínica con información detallada para el análisis de las variables de estudio.

Criterios de Exclusión

Se excluirán del estudio a las pacientes que presente uno o más de los siguientes criterios:

1. Fémimas menores de 15 años y mayores de 49 años.
2. Pacientes que no hayan sido evaluadas durante el periodo y lugar de evaluación.
3. Fémimas que no se hayan realizado la prueba de Papanicolaou.
4. Pacientes con historia clínica incompleta o con datos insuficientes para la evaluación de las variables de estudio.
5. Diagnóstico previo de Cáncer de Cuello Uterino.
6. Pacientes con antecedente de histerectomía total.

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.8.1. Técnica

La técnica por utilizar es la revisión de Historia clínica de las féminas en edad fértil (15-49 años) con resultado alterado de la prueba de Papanicolaou, evaluadas en el servicio de Obstetricia del Establecimiento de Salud Mirones Bajo, Lima, 2024.

3.8.2. Descripción de instrumentos

El instrumento por utilizar es una ficha de recolección de datos estructurado de elaboración propia, diseñado por la investigadora en base a los objetivos del estudio, marco teórico y variables establecidas en la matriz de consistencia: factores asociados (factores sociodemográficos, gineco-obstétricos y conductuales) y lesiones cervicales premalignas (LIE bajo y alto grado).

La ficha de recolección de datos está conformada por un total de 12 ítems, distribuidos en dos secciones, la primera correspondiente al tipo de lesión cervical premaligna (1 ítem) y el segundo en los factores asociados: factores sociodemográficos (3 ítems) , gineco-obstétricos (7 ítems) y conductuales (2 ítems); cada uno de ellos permitirán la recopilación de información relevante de las féminas entre 15 a 49 años en relación con las lesiones cervicales premalignas.

Cada sección de la ficha de recolección de datos está orientada en medir las variables de investigación; los ítems se diseñaron utilizando escalas nominales y ordinales, según la naturaleza de cada indicador. El instrumento incluyó ítems sobre lesiones cervicales premalignas (LIE bajo y alto grado, ASCUS, ASCH, AGC), factores sociodemográficos (edad, estado conyugal, grado de instrucción) , gineco-obstétricos (paridad, gestación, inicio de relaciones sexuales, antecedente de infecciones de transmisión sexual, antecedente familiar de

cáncer de cuello uterino, método anticonceptivo y número de parejas sexuales) y conductuales (alcoholismo y tabaquismo). En instrumento completo se presenta en el Anexo 1.

3.8.3. Validación

El instrumento ha sido validado mediante juicio de expertos, la cual consistió en someter el instrumento a una evaluación crítica de especialistas con experiencia en el tema de investigación y así garantizar su validez de contenido.

Para esta fase, se contó con la participación de 3 expertos en el área de salud sexual y reproductiva, con conocimientos específicos en la prueba de Papanicolaou y diseño de instrumentos de investigación. A cada uno de ellos se les entregó una matriz de validación, donde evaluaron cada ítem de la ficha de recolección de datos según tres criterios: pertinencia, relevancia y claridad con las dimensiones e indicadores de las variables. Los resultados de la evaluación del instrumento por los expertos fueron aprobatorios.

3.8.4. Confiabilidad

La confiabilidad del instrumento en esta investigación está orientado a la consistencia y estabilidad de los datos recolectados a partir del expediente clínico de las pacientes evaluadas en el servicio de obstetricia del Establecimiento de Salud Mirones Bajo.

Se utilizará una ficha de recolección de datos estructurada, elaborada por la investigadora, la cual permitirá registrar de manera sistemática la información objetiva previamente consignada en las historias clínicas, tales como edad, estado conyugal, grado de instrucción, antecedentes gineco-obstétricos, resultados del Papanicolaou, entre otros.

Dado que el instrumento no mide actitudes ni percepciones, no se aplicaron pruebas estadísticas de consistencia interna, como el coeficiente de Alfa de Cronbach; en su lugar, la confiabilidad será garantizada mediante la aplicación uniforme de la ficha y el uso de fuentes

institucionales verificables. Además, la ficha fue validada por juicio de expertos, quienes revisaron la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems, contribuyendo así a fortalecer la validez y la confiabilidad del instrumento utilizado en el estudio.

3.9. Plan de procesamiento y análisis de datos

Los datos obtenidos a través de la ficha de recolección serán revisados, organizados y codificados para luego ser ingresados en una base de datos utilizando el programa Microsoft Excel 2019. Posteriormente, se realizará el análisis estadístico en el software IBM SPSS Statistics, con el objetivo de dar respuesta a los objetivos específicos del estudio.

Primero, se realizará el análisis descriptivo, se ingresarán y organizarán los datos en el programa Microsoft Excel 2019 para calcular las frecuencias y porcentajes de cada ítem con gráficos descriptivos y revisar los errores.

Segundo, para realizar el análisis inferencial con el programa IBM SPSS Statistics, se aplicará la prueba estadística del Chi Cuadrado (χ^2), esta es una herramienta estadística que se utiliza para saber si dos variables categóricas están relacionadas, se utilizará para determinar la asociación entre los factores asociados y las lesiones cervicales premalignas, se considerará un resultado estadísticamente significativo cuando el valor de p sea menor de 0.05 ($p < 0.05$). (59) En los casos donde se observe asociación significativa entre las variables se calculará la magnitud o fuerza de dicha asociación mediante el Odds ratio junto con su intervalo de confianza (IC 95%), la cual es una medida estadística que determina dicha asociación entre una variable de exposición (factor asociado) y el desenlace (lesión premaligna), esto nos indicará cuan probable es que ocurra el desenlace del grupo expuesto en comparación con el no expuesto; si el OR es mayor a 1, indica una mayor probabilidad de que ocurra el evento en el grupo expuesto; si es menor a 1, indica menor probabilidad. (60)

3.10. Aspectos éticos

En la presente investigación se respetará la confidencialidad y protección de la privacidad de datos de las pacientes involucradas; no se tergiversarán los resultados ni información contenida, se compartirán los hallazgos de manera ética; además, este proyecto será evaluado por el comité de ética de la Universidad Privada Norbert Wiener, cumpliendo con los principios éticos básicos. En este estudio no se utilizará el consentimiento informado, ya que la recolección de datos será a través de una ficha de recolección utilizando historias clínicas.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Recursos y Presupuesto

	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Investigador	0	1	0.00
Estadístico	150.00	1	150.00
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS (BIENES)			
Hojas Bond	15.70	1 paquete	15.70
Lapiceros	2.00	½ docena	12.00
Memoria USB 8GB	25.00	1	25.00
SERVICIOS			
Internet	55.00	2 meses	110.00
Fotocopias	100	0.10	10.00
Movilidad	6.00	15 días	90.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O IMPREVISTOS			
Imprevistos			100.00

TOTAL			512.70
--------------	--	--	--------

4.2. Cronograma de Actividades

N	Actividad	2025						
		May	Jun	Jul	Ago	Sept	Nov	Dic
1	Elección del tema	x						
2	Búsqueda bibliográfica	x						
3	Elaboración del proyecto	x	x	x				
4	Instrumento de recolección		x	x				
5	Coordinación con el establecimiento				x	x		
6	Recolección de datos						x	
7	Procesamiento de los datos						x	
8	Análisis de datos						x	
9	Corrección de estilo							x
10	Elaboración del informe final de tesis							x
11	Sustentación							x

5. REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la salud. Cáncer de cuello uterino. OMS. [Internet] 2024 [citado 25 nov 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
2. Pimple S, Mishra G. Cancer cervix: Epidemiology and disease burden. Cytojournal. [Interent] 2022 Mar [citado 25 nov 2024]. 29;19:21. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9063649/#ref3>

3. Guo C, Qu X, Tang X, Song Y, Wang J, Hua K, Qiu J. Spatiotemporally deciphering the mysterious mechanism of persistent HPV-induced malignant transition and immune remodelling from HPV-infected normal cervix, precancer to cervical cancer: Integrating single-cell RNA-sequencing and spatial transcriptome. Clin Transl Med. [Internet] 2023 Mar [citado 25 nov 2024]; 13(3):e1219. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10040725/#ctm21219-bib-0002>
4. Ministerio de Salud. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Minsa. [Internet] 2024 [citado 25 nov 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/21445-que-es-el-cancer-de-cuello-uterino>
5. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. SALA SITUACIONAL DE CÁNCER EN EL PERÚ I Trimestre 2024. Minsa. [Internet] 2024 [citado 25 nov 2024]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2024/SE24/cancer.pdf>
6. Sharma S, Chauhan D, Kumar S, Kumar R. Impact of HPV strains on molecular mechanisms of cervix cancer. Microbial Pathogenesis. [Internet] 2024 Ene [citado 27 nov 2024]; 186:106465. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882401023004989?via%3Dihub>
7. Zhang T, Zhuang L, Muaibati M, Wang, D, Abasi A, Tong A, Ma D, Jin L, Huang X. Identification of cervical cancer stem cells using single-cell transcriptomes of normal cervix, cervical premalignant lesions, and cervical cancer. EBioMedicine. [Internet] 2023 Jun [citado 27 nov 2024]; 92:104612. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10277926/>
8. Ili C, López J, Reyes M, Viscarra T, Buchegger K, Zanella L, Aguayo F, Brebi P. Detección e integración del virus del papiloma humano de alto riesgo en lesiones pre-

- neoplásicas en mujeres del sur de Chile: un estudio transversal. Rev. Chil. [Internet] 2024 [citado 27 nov 2024]. 41(1). Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182024000100027&lang=es
9. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. [Internet] 2021 [citado 08 dic 2024]; 71(3):209-249. Disponible en: <https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21660>
10. Puga O, Belmar F, Pertossi E. Prevención y detección precoz del cáncer cervicouterino. Rev. Med. Clin. Condes. [Internet] 2024 [citado 08 dic 2024]; 35(2):95-105. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-prevencion-deteccion-precoz-del-cancer-S0716864024000208?utm_source=chatgpt.com
11. Ramos D, Lorié L, González A. Factores de riesgo de lesiones premalignas del cérvix en edad reproductiva. Policlinico Omar Ranedo 2020. CU. Salud. [Internet] 2022 [citado 08 dic 2024]. Disponible en: <https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/viewFile/466/1621>
12. Kurtay S, Ali K, Hussein A. Frequency of cervical premalignant lesions in the gynecologic patients of a tertiary hospital in Mogadishu, Somalia. BMC Women's Health. [Internet] 2022 [citado 11 dic 2024]. 22:501. Disponible en: <https://bmcmwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-022-02106-0#citeas>

13. Yordanov A, Vasileva-Slaveva M, Galai N, Faraggi D, Kubelac MP, Tripac-Iacovleva I, Calleja N, Di Fiore R, Calleja-Agius J. Cancer of the Cervix in Bulgaria: Epidemiology of a Crisis. *Healthcare (Basel)*. [Internet] 2023 [citado 28 nov 2024]; 11(3):318. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914859/>
14. Lakkis NA, Osman MH, Abdallah RM. Cervix Uteri Cancer in Lebanon: Incidence, Temporal Trends, and Comparison to Countries from Different Regions in the World. *Cancer Control*. [Internet] 2022 [citado 28 nov 2024]; 29:10732748211068634. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8755921/>
15. Aviles S, Gonzalo W, Mejia A. Factores de riesgo asociados a las anormalidades cérvico-uterinas en el papanicolaou realizado en un centro especializado neoplásico, Concepción Huancayo, 2020 – 2021. [Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano]. Huancayo: Universidad Continental; 2023 [citado 08 dic 2024]. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/12926/8/IV_FCS_502_TE_Aviles_Gonzalo_Mejia_2023.pdf
16. Ruiz R. Factores asociados a lesiones intraepiteliales de cérvix en usuarias del Hospital San Juan de Lurigancho, 2018. [Tesis para optar el Grado de Maestra en Obstetricia con Mención en Salud Reproductiva]. Lima: Universidad San Martin de Porres; 2021 [citado 08 dic 2024]. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/8344/Ruiz%20_%20V_RB.pdf?sequence=1
17. Torné A. Aspectos clínicos de las lesiones precursoras y del cáncer de cérvix. *Medicina de Familia. SEMERGEN*. [Internet] 2007 [citado 11 dic 2024]. 33(S2):22-26. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-aspectos-clinicos-lesiones-precursoras-del-X1138359307908289>

18. Vere M. Risk Factors for Cervical Precancer Lesions among Women Attending Cervical Cancer Screening Clinics in Harare, 2013. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciatura en Medicina]. Zimbabue: Universidad de Zimbabue; 2013 [citado 12 dic 2024]. Disponible en: https://www.academia.edu/71978516/1_Risk_Factors_for_Cervical_Precancer_Lesions_among_Women_Attending_Cervical_Cancer_Screening_Clinics_in_Harare_2013_By?nav_from=31467bd0-096c-444f-9805-1489717c725a
19. Ministerio de Salud. GUÍA TÉCNICA: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. MINSA. [Internet] 2016 [citado 08 nov 2025]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/192692/guia-de-practica-clinica-para-la-prevencion-y-manejo-del-cancer-de-cuello-uterino.pdf?v=1593817068>
20. Ministerio de Salud. DOCUMENTO TÉCNICO: PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 2017-2021. MINSA. [Internet] 2017 [citado 08 nov 2025]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189961/189456_RM_440-2017.PDF20180823-24725-2h2g8z.PDF?v=1535064303
21. Ministerio de Salud. DIRECTIVA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO MEDIANTE LA DETECCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE LESIONES PRE MALIGNAS INCLUYENDO CARCINOMA IN SITU. MINSA. [Internet] 2019 [citado 08 nov 2025]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/337895/resolucion-ministerial-576-2019-minsa.PDF?v=1561830044>
22. Ministerio de Salud. DIRECTIVA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. MINSA. [Internet] 2025 [citado 08 nov 2025]. Disponible en:

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8382888/6972661-resolucion-ministerial-n-480-2025-minsa.pdf?v=1752847841>

23. Moreno M. Actualización en el reporte de citología cervicovaginal basado en el Sistema Bethesda 2014. Rev Obstet Ginecol Venez. [Internet]. 2017 [citado 11 dic 2024]. 77(1): 58-66. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322017000100008
24. Kattoor J, Kamal MM. The gray zone squamous lesions: ASC-US / ASC-H. Cytojournal. [Internet]. 2022 [citado 11 dic 2024]. 19:30. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9168398/>
25. Wang T, Zhang H, Liu Y, Zhao C. Updates in Cervical Cancer Screening Guidelines, The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, and Clinical Management Recommendations. J Clin Transl Pathol. [Internet]. 2023 [citado 11 dic 2024]. 3(2):75-83. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10348779/>
26. Chiaffarano JM, Alexander M, Rogers R, Zhou F, Cangiarella J, Yee-Chang M, Elgert P, Simsir A. "Low-grade squamous intraepithelial lesion, cannot exclude high-grade:" TBS says "Don't Use It!" should I really stop it? Cytojournal. [Internet]. 2017 [citado 12 dic 2024]. 14:13. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5458421/>
27. Alrajjal A, Pansare V, Choudhury MSR, Khan MYA, Shidham VB. Squamous intraepithelial lesions (SIL: LSIL, HSIL, ASCUS, ASC-H, LSIL-H) of Uterine Cervix and Bethesda System. Cytojournal. [Internet] 2021 [citado 11 dic 2024]. 18:16. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8326095/>
28. Getinet M, Taye M, Ayinalem A, Gitie M. Precancerous Lesions of the Cervix and Associated Factors among Women of East Gojjam, Northwest Ethiopia, 2020. Cancer Management and Research. [Internet] 2021 [citado 12 dic 2024]. 13: 9401-9410.

Disponible en: <https://www.dovepress.com/precancerous-lesions-of-the-cervix-and-associated-factors-among-women-peer-reviewed-fulltext-article-CMAR>

29. Zhang M, Wang H, Ding R, Li W, He P, Li H. Prevalence and risk factors of cervical lesion among married women with low socioeconomic status: a study based on a cervical cancer screening program. Research Square. [Internet] 2024 [citado 13 dic 2024]. Disponible en: <https://www.researchsquare.com/article/rs-4235811/v1>
30. Abera GB, Yebyo HG, Hailekiros H, Niguse S, Berhe Y, Gigar G, Asmelash T, Goba G. Epidemiology of pre-cancerous cervical lesion and risk factors among adult women in Tigray, Ethiopia. PLoS One. [Internet] 2023 [citado 13 dic 2024];18(1):e0280191. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9821489/#:~:text=About%208.9%25%20and%203.96%25%20of,regional%20prevalence%20in%20the%20country.>
31. Instituto Nacional de Estadística e informática. Perú: Caracterización de las Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2015. INEI. [Internet] 2016 [citado 13 dic 2024]; 6: 64. Disponible en: <https://www.conadisperu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/PERU-CARACTERIZACI%C3%93N-DE-LAS-CONDICIONES-DE-VIDA-DE-LA-POBLACI%C3%93N-CON-DISCAPACIDAD-2015Libro.pdf>
32. Gede N, Kurniawan I. Characteristics of Cervical Precancerous Lesions at a Tertiary Hospital in Bali, Indonesia. Indonesian Journal of Cancer. [Internet] 2020 [citado 13 dic 2024]; 14(4): 117-120. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/348022496_Characteristics_of_Cervical_Precancerous_Lesions_at_a_Tertiary_Hospital_in_Bali_Indonesia
33. Sarduy M. Características clínicas y sociodemográficas en un grupo de mujeres con lesiones escamosas intraepiteliales cervicales de alto grado. Rev Cubana Obstet

- Ginecol. [Internet] 2008 [citado 13 dic 2024]. 34(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2008000200008&lng=es.
34. Mruzek H, Bartnik J, Bidzinska A, Ciebiera M, Derlatka L, Derlatka P. Early-Stage and Locally Advanced Cervical Cancer during Pregnancy: Clinical Presentation, Diagnosis and Treatment. *Medicina*. [Internet] 2024 [citado 13 dic 2024]. 60:1700. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1648-9144/60/10/1700>
 35. Beyene T, Akibu M, Bekele H, Seyoum W. Determinants of precancerous cervical lesion among women screened for cervical cancer in south Ethiopia: A case-control study. *Research Square*. [Internet] 2019 [citado 12 dic 2024]. Disponible en: https://www.academia.edu/93972029/Determinants_of_precancerous_cervical_lesion_among_women_screened_for_cervical_cancer_in_south_Ethiopia_A_case_control_study?nav_from=dcef4632-b64c-4d75-943b-3d807850395a
 36. Leal I, Molina T, Luttges C, González E, Gonzalez D. Edad de inicio sexual y asociación a variables de salud sexual y violencia en la relación de pareja en adolescentes chilenos. *Rev. chil. obstet. ginecol.* [Internet] 2018 [citado 12 ene 2025]; 83(2):149-160. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262018000200149
 37. Zena D, Elfu B, Mulatu K. Prevalence and Associated Factors of Precancerous Cervical Lesions among Women in Ethiopia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ethiop J Health Sci.* [Internet] 2021 [citado 12 dic 2024]. 31(1):189. Disponible en: https://www.academia.edu/69559704/Prevalence_and_Associated_Factors_of_Precancerous_Cervical_Lesions_among_Women_in_Ethiopia_A_Systematic_Review_and_Meta_Analysis?nav_from=bab4ee19-2cb0-4fd0-94a0-a613460ec3db

38. Yang D, Zhang J, Cui X, Ma J, Wang C and Piao H. Risk Factors Associated With Human Papillomavirus Infection, Cervical Cancer, and Precancerous Lesions in Large-Scale Population Screening. *Front. Microbiol.* [Internet] 2022 [citado 12 dic 2024]. 13:914516. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2022.914516/full>
39. Basu P, Taghavi K, Hu S, Mogri S, Joshi S. Management of cervical premalignant lesions. *Current Problems in Cancer.* [Internet] 2018 [citado 12 dic 2024]. 42(2): 129-136. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147027217301952>
40. Worku E, Yigizaw G, Admassu R, Mekonnen D, Gessessa W, Tessema Z, Walle T. Prevalence and risk factors associated with precancerous and cancerous cervical lesions among HIV-infected women in University of Gondar specialized comprehensive referral hospital, Northwest Ethiopia: cross-sectional study design. *BMC Women's Health.* [Internet] 2024 [citado 12 dic 2024]. 24: 322. Disponible en: <https://bmcmwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-024-03174-0#citeas>
41. Gallardo K, Cunningham W. Factores de riesgos en mujeres diagnosticadas con lesiones pre-malignas de cáncer cérvicouterino. *Rev. Univ. Carib.* [Internet] 2018 [citado 12 ene 2025]; 21(2): 71-83. Disponible en: <https://camjol.info/index.php/RUC/article/view/7766/7306>
42. Taye B, Mihret M, Muche H. Risk factors of precancerous cervical lesions: The role of women's socio demographic, sexual behavior and body mass index in Amhara region referral hospitals; case-control study. *PLoS ONE.* [Internet] 2021 [citado 12 dic 2024]. 16(3): e0249218. Disponible en:

https://www.academia.edu/108579803/Risk_factors_of_precancerous_cervical_lesions_The_role_of_women_s_socio_demographic_sexual_behavior_and_body_mass_index_in_Amhara_region_referral_hospitals_case_control_study?nav_from=9072d20a-7648-4b6a-9668-a4fa840fbaf5

43. Tenkir L, Mamuye A, Jemebere W, Yeheyis T. MAGNITUDE OF PRECANCEROUS CERVICAL LESIONS AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG WOMEN SCREENED FOR CERVICAL CANCER AT A REFERRAL CENTER IN SOUTHERN ETHIOPIA, 2021: A CROSS-SECTIONAL STUDY. *Frontiers in Global Women's Health*. [Internet] 2023 [citado 12 dic 2024]. Disponible en: https://www.academia.edu/118238004/The_magnitude_of_precancerous_cervical_lesions_and_its_associated_factors_among_women_screened_for_cervical_cancer_at_a_referral_center_in_southern_Ethiopia_2021_a_cross_sectional_study?nav_from=0950e16b-bf6a-4ac7-b411-7990511167b3
44. Mulumba R, Lule H, Atuhaire C, Bonet I, Diaz A. Prevalence and Factors Associated with Cervical Premalignant Lesions in Women 25-65 Years Attending Gynaecology Clinic at Kampala International University Teaching Hospital. *Sch. J. App. Med. Sci.* [Internet] 2018 [citado 12 dic 2024]. 6(3): 818-832. Disponible en: https://www.academia.edu/36556495/Prevalence_and_Factors_Associated_with_Cervical_Premalignant_Lesions_in_Women_25_65_Years_Attending_Gynaecology_Clinic_at_Kampala_International_University_Teaching_Hospital
45. Grabovac I, Smith L, Yang L, Soysal P, Veronese N, Turan A, Forwood S, Jackson A. The relationship between chronic diseases and number of sexual partners: an exploratory analysis. *BMJ Sex & Reprod Health*. [Internet] 2020 [citado 12 ene 2025]. 46: 100-107. Disponible en: <https://srh.bmj.com/content/familyp planning/46/2/100.full.pdf>

46. Temesgen K, Workie M, Dilnessa T, Abate M. Proportions of Pre-Cancerous Cervical Lesions and Its Associated Factors among Women Clients in the Age Group of 30-49yrs in Gynecology Ward of Dessie Referral Hospital and FGAE, North-East Ethiopia, 2016. Journal Cancer and Tumor International. [Internet] 2019 [citado 12 dic 2024]. 9(2): 1-15. Disponible en: https://www.academia.edu/50701538/Proportions_of_Pre_Cancerous_Cervical_Lesions_and_Its_Associated_Factors_among_Women_Clients_in_the_Age_Group_of_30_49yrs_in_Gynecology_Ward_of_Dessie_Referral_Hospital_and_FGAE_North_East_Ethiopia_2016?nav_from=219e03be-fcd2-4c1e-af7a-36ced3d61947
47. Posso A, Rangel M, Marchán N, González M. Lesión intraepitelial cervical en adolescentes. Rev Obstet Ginecol Venez [Internet] 2014 [citado 20 ene 2025]; 74(3):193-202. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322014000300008&lng=es.
48. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar. Minsa. [Internet] 2017 [citado 11 dic 2024]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>
49. Diaz S. Guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de Lesiones preinvasoras de cérvix. Hospital Nacional Cayetano Heredia. [Internet] 2024 [citado 11 dic 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7122581/6118033-rd-n-292-2024-hnch-dg.pdf>
50. Vikrant V. Sahasrabuddhe. Cervical Cancer: Precursors and Prevention. Hematology/Oncology Clinics of North America. [Internet] 2024 [citado 11 dic 2024]. 38(4):771-781. Disponible en:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889858824000327?via%3Dihub>

51. Nayar R, Wilbur DC. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: A Historical Perspective. *Acta Cytol.* [Internet] 2017 [citado 11 dic 2024]. 61(4-5):359-372. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28693017/>
52. Pangarkar MA. The Bethesda System for reporting cervical cytology. *Cytojournal.* [Internet] 2022 [citado 11 dic 2024]. 19:28. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9168399/>
53. Chatterjee T, Gill SS, Rac R. STANDARDIZATION OF CERVICAL/VAGINAL CYTOPATHOLOGY REPORTING: THE BETHESDA SYSTEM (TBS) FOR REPORTING CERVICAL/VAGINAL CYTOLOGIC DIAGNOSES. *Med J Armed Forces India.* [Internet] 2017 [citado 11 dic 2024]; 56(1):45-49. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5531959/>
54. Arbulu C. Definición de método hipotético-deductivo. ResearchGate. [Internet] 2023 [citado 18 dic 2024]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/374898591_Definicion_de_metodo_hipotetico-deductivo
55. Creswell J, Creswell D. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5 ed. [Internet] Los Angeles: SAGE; 2018. [citado 18 dic 2024]. Disponible en: https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
56. Salmons J. What is the difference between experimental and non-experimental research designs? SAGE. [Internet] 2023 [citado 22 dic 2024]. Disponible en: <https://researchmethodscommunity.sagepub.com/blog/quantitative-research-with-non-experimental-designs>

57. Setia MS. Methodology Series Module 3: Cross-sectional Studies. Indian J Dermatol. [Internet] 2016 [citado 22 dic 2024]; 61(3):261-4. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4885177/>
58. Bhandari P. Correlational Research | When & How to Use. Scribbr. [Internet] 2021 [citado 22 dic 2024]. Disponible en: <https://www.scribbr.com/methodology/correlational-research/>
59. Sei Y, Ohsuga A. Privacy-preserving chi-squared test of independence for small samples. BioData Min. [Internet] 2021 [citado 26 mar 2025]; 14(1):6. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7820106/>
60. Szumilas M. Explaining odds ratios. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. [Internet] 2010 [citado 26 mar 2025]; 19(3):227-9. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2938757/>

6. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Recolección de Datos

Ficha de recolección de datos

I. Lesión cervical premaligna

- a. LIE bajo grado
- b. LIE alto grado
- c. ASCUS
- d. ASCH
- e. AGC

II. Dimensión: Factores Sociodemográficos

- 1. Mujer en edad fértil (15 a 49 años)
 - a. Etapa Adolescente (15 a 17)
 - b. Juventud (18-29)
 - c. Etapa adulta (30-49)
- 2. Estado conyugal
 - a. Mujeres en Unión
 - b. Mujeres que no están en Unión
- 3. Grado de instrucción
 - a. Primaria
 - b. Secundaria
 - c. Superior Técnico
 - d. Superior Universitario

III. Dimensión: Factores Gineco-Obstétricos

- 4. Paridad
 - a. Primípara
 - b. Multípara
- 5. Gestación durante la detección de lesiones cervicales premalignas
 - a. Si
 - b. No
- 6. Edad de inicio de relaciones sexuales
 - a. Inicio sexual temprano (<15 años)
 - b. Inicio sexual no temprano (≥ 15 años)

- 7. Antecedente de infección de transmisión sexual
 - a. Si
 - b. No
- 8. Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino
 - a. Si
 - b. No
- 9. Método anticonceptivo utilizado regularmente
 - a. De barrera
 - b. Hormonal
 - c. Definitivo
- 10. Número de parejas sexuales
 - a. 1 (Muy bajo historial)
 - b. 2-4 (bajo historial)
 - c. 5-9 (moderado historial)
 - d. >9 (alto historial)

IV. Dimensión: Factores Conductuales

- 11. Consume tabaco regularmente
 - a. Si
 - b. No
- 12. Consumen alcohol regularmente
 - a. Si
 - b. No

Anexo 2: Validez del Instrumento

Nº	DIMENSIONES	PERTINENCIA		RELEVANCIA		CLARIDAD		SUGERENCIA
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
VARIABLE: FACTORES ASOCIADOS A LESIONES CERVICALES PREMALIGNAS								
DIMENSIÓN 1: FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS								
1	Mujer en edad fértil (15 a 49 años)							
2	Estado conyugal							
3	Grado de instrucción							
DIMENSIÓN 2: FACTORES GINECO-OBSTÉTRICOS								
4	Paridad							
5	Gestación durante la detección de lesiones cervicales premalignas							
6	Edad de inicio de relaciones sexuales							
7	Antecedente de infección de transmisión sexual							
8	Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino							
9	Método anticonceptivo utilizado regularmente							
10	Número de parejas sexuales							
DIMENSIÓN 3: FACTORES CONDUCTUALES								
11	Consume Tabaco regularmente							
12	Consume Alcohol regularmente							

1. Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2. Relevancia: el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

3. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable []

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. DNI:

Especialidad del validador: _____

	transmisión sexual							
8	Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino	x						
9	Método anticonceptivo utilizado regularmente	x						
10	Número de parejas sexuales	x						
DIMENSIÓN 3: FACTORES CONDUCTUALES								
11	Consume Tabaco regularmente	x						
12	Consume Alcohol regularmente	x						

1. Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2. Relevancia: el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

3. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [si]

Aplicable después de corregir []

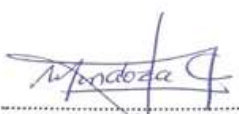
No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. Janet Giovanna Mendoza Cama

Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud

DNI: 40554250

Especialidad del validador: Obstetra


Janet Mendoza Cama
MAESTRA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD
OBSTETRA
COP. 18691

11 de Febrero de 2025

	transmisión sexual							
8	Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino	X		X		X		
9	Método anticonceptivo utilizado regularmente	X		X		X		
10	Número de parejas sexuales	X		X		X		
DIMENSIÓN 3: FACTORES CONDUCTUALES								
11	Consume Tabaco regularmente	X		X		X		
12	Consume Alcohol regularmente	X		X		X		

1. Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2. Relevancia: el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

3. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad:

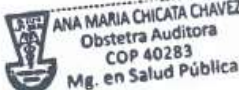
Aplicable [☒ X]

Aplicable después de corregir [☐] No aplicable [☐]

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg. DNI:

Mg. Obst. Ana Maria Chicata Chavez DNI: 70918005

Especialidad del validador: Maestro en Salud Pública

11 de Febrero de 2025

	transmisión sexual	☒		☒		☒	
8	Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino	☒		☒		☒	
9	Método anticonceptivo utilizado regularmente	☒		☒		☒	
10	Número de parejas sexuales	☒		☒		☒	
DIMENSIÓN 3: FACTORES CONDUCTUALES							
11	Consume Tabaco regularmente	☒		☒		☒	
12	Consume Alcohol regularmente	☒		☒		☒	

1. Pertinencia: el ítem corresponde al concepto teórico formulado.

2. Relevancia: el ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

3. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota. Suficiencia: se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ☒

Aplicable después de corregir []

No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./Mg.

Mg. Karen Ramos Miranda

DNI: 73689382

Especialidad del validador: Magister en Gerencia Simoes School

- Especialista Simoes Especialidad Montañas
- Fetal y Diagnóstico por Imágenes en Obstetricia
- Auditora en Salud - RENOSAP 338

11 de Febrero de 2025


Karen L. Ramos Miranda
OBSTETRA
RPM 3382


Mg. Karen Ramos Miranda
OBSTETRA
RPM 3382

Anexo 3: Informe del Asesor de Turnitin

Similarity Report

6% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 4% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1

uwiener on 2023-05-23

Submitted works

<1%

2

repositorio.uwiener.edu.pe

Internet

<1%

3

hdl.handle.net

Internet

<1%

4

dspace.uce.edu.ec

Internet

<1%

5

coursehero.com

Internet

<1%

6

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,UNAD on 2024-05-14

Submitted works

<1%

7

Universidad Católica de Santa María on 2016-03-14

Submitted works

<1%

8

docplayer.es

Internet

<1%

Sources overview

9	repositorio.unfv.edu.pe	<1%
	Internet	
10	Universidad de San Martín de Porres on 2021-05-03	<1%
	Submitted works	
11	repositorio.uma.edu.pe	<1%
	Internet	
12	Universidad Anahuac México Sur on 2024-02-05	<1%
	Submitted works	
13	Universidad Wiener on 2022-11-28	<1%
	Submitted works	
14	repositorio.ucv.edu.pe	<1%
	Internet	
15	Universidad Wiener on 2025-04-10	<1%
	Submitted works	
16	repositorio.unsch.edu.pe	<1%
	Internet	
17	slideshare.net	<1%
	Internet	
18	Universidad Wiener on 2024-12-01	<1%
	Submitted works	
19	cladlalibertad.org.pe	<1%
	Internet	
20	Universidad Católica de Santa María on 2017-01-18	<1%
	Submitted works	

[Sources overview](#)

21	Universidad Católica de Santa María on 2025-03-18 Submitted works	<1%
22	Universidad Wiener on 2022-11-18 Submitted works	<1%
23	Universidad Wiener on 2023-11-24 Submitted works	<1%
24	prezi.com Internet	<1%
25	repositorio.ucp.edu.pe Internet	<1%
26	medigraphic.com Internet	<1%

Anexo 4: Matriz de Consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Diseño metodológico
Problema General: ¿Cuáles son los factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024? Problemas Específicos: ¿Cuáles son los factores sociodemográficos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024? ¿Cuáles son los factores gineco-obstétricos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024? ¿Cuáles son los factores conductuales asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en	Objetivo General: Identificar los factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024. Objetivos específicos: Distinguir los factores sociodemográficos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024. Reconocer los factores gineco-obstétricos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024. Identificar los factores conductuales asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres	Hipótesis General: Existen factores asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024. Hipótesis Específicas: Existen factores sociodemográficos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024. Existen factores gineco-obstétricos asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024. Existen factores conductuales asociados a las lesiones cervicales premalignas detectadas mediante la prueba de Papanicolaou en mujeres	Variable: Factores Asociados Dimensiones: Factores sociodemográficos Factores gineco-obstétricos Factores conductuales Variable: Lesiones Cervicales Premalignas Dimensión: Grado de la lesión cervical premaligna (LIE alto y bajo grado)	Tipo de investigación, método y diseño de la investigación: Método: hipotético deductivo, Enfoque: cuantitativo Tipo: aplicada Diseño: no experimental Corte: transversal Nivel: Correlacional Población: 38 historias clínicas de las mujeres en edad fértil (15-49 años) con resultado alterado de la prueba de Papanicolaou evaluadas en el consultorio de obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima, 2024. Muestra: Se ha considerado el total de la población de estudio Técnica: Revisión de Historia clínica Instrumento: ficha de recolección de datos.

edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024?	en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.	en edad fértil atendidas en el consultorio de Obstetricia del Centro de Salud Mirones Bajo, Lima 2024.		
---	--	--	--	--

Anexo 5: Cuadro de Operacionalización de Variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Factores asociados	Condiciones que influyen en la aparición de las lesiones cervicales premalignas.	Características presentadas en mujeres en edad fértil asociadas a lesiones cervicales premalignas.	Factores Sociodemográficos	Edad	Nominal	Mujer en edad fértil (15 a 49 años) a. Etapa Adolescente (15 a 17) b. Juventud (18-29) c. Etapa adulta (30-49)
				Estado Conyugal	Nominal	a. Mujeres en Unión b. Mujeres que no están en unión
				Grado de instrucción	Ordinal	a. Primaria b. Secundaria c. Estudios superiores
			Factores Gineco-obstétrico	Paridad	Nominal	a. Primípara b. Multípara
				Gestante	Nominal	a. Si b. No
				Inicio de relaciones sexuales	Intervalo	a. Inicio sexual temprano (<15 años) b. Inicio sexual no temprano (≥ 15 años)

				Antecedente de Infección de transmisión sexual	Nominal	a. Si b. No
				Antecedente familiar de Cáncer de Cuello Uterino	Nominal	a. Si b. No
				Clase de método anticonceptivo usado	Nominal	a. De barrera b. Hormonal c. Definitivo
				Número total de parejas sexuales	Nominal	a. 1 (Muy bajo historial) b. 2-4 (bajo historial) c. 5-9 (moderado historial) d. >9 (alto historial)
			Factores conductuales	Tabaquismo	Nominal	a. Si b. No
				Alcoholismo	Nominal	a. Si b. No
Lesiones cervicales premalignas	Modificaciones celulares del cérvix que podrían volverse cáncer.	Se identifica mediante el resultado de la prueba de Papanicolaou realizada en mujeres en edad fértil.	Grado de la lesión cervical premaligna.	Resultado citológico de la Prueba de Papanicolaou	Nominal	a. LIE bajo Grado b. LIE alto grado c. ASCUS d. ASCH e. AGC

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Lima, 24 de julio del 2025.

Autor Responsable:

Naghely Khalita Carhuavilca Alvarado

Exp. Nº: 0652-2025

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEIC-UPNW) evaluó y **APROBÓ** el siguiente proyecto de investigación:

Proyecto Titulado: "FACTORES ASOCIADOS A LAS LESIONES CERVICALES PREMALIGNAS DETECTADAS MEDIANTE LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO DE OBSTETRICIA DEL CENTRO DE SALUD MIRONES BAJO, LIMA 2024" Versión Nro. 1, con fecha 29/05/2025.

El cual tiene como Autor(es) a:

Naghely Khalita Carhuavilca Alvarado

La **APROBACIÓN** comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

- La **vigencia** de la aprobación es **24 meses** a partir de la emisión de este documento.
- Toda **enmienda** deberá presentarse al CIEIC-UPNW; el proyecto no podrá ejecutarse sin su aprobación previa.
- La constancia de aprobación por el CIEIC **no garantiza** la **aceptación** por parte de las **instituciones** donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener

Lima, Martes 14 de Octubre de 2025

CARTA N° 0388-2025-SG-UPNW-CP

Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente

Director General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

Redes Integradas de Salud Lima Centro.

Av. Nicolás de Piérola 589, Lima.

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez presentar a la bachiller de la carrera profesional de **OBSTETRICIA; NAGHELY KHALITA CARHUAVILCA ALVARADO** con código de matrícula **N° 2019100763** con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos en **Historia Clínica de las Fémias en Edad Fértil (15 a 49 años) con resultado alterado de la prueba de Papanicolaou, evaluadas en el servicio de Obstetricia del C.S. Mirones Bajo.**

Toda la información que solicita la tesista **NAGHELY KHALITA CARHUAVILCA ALVARADO** para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **“FACTORES ASOCIADOS A LAS LESIONES CERVICALES PREMALIGNAS DETECTADAS MEDIANTE LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO DE OBSTETRICIA DEL CENTRO DE SALUD MIRONES BAJO, LIMA 2024”** dirigido por la asesoría de tesis de **Mg. DIEZ QUEVEDO KARINA**, para la obtención del título profesional en **LICENCIADA EN OBSTETRICIA.**

Agradeciendo por anticipado su autorización a la tesista para que logre su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Khristian Vigil Vega
DNI: 44025157
RUC: 20466246370
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/10/2025 Hora: 09:13:57



Universidad
Norbert Wiener

Khristian Vigil Vega

Secretario General

Universidad Privada Norbert Wiener S.A.